Kidney Week 2026 a nové údaje pre individuálnu nefrologickú starostlivosť

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 08.11.2026



Ilustračná poloschematická scéna spája funkciu obličiek, mimotelové čistenie krvi a výživu. Nezobrazuje konkrétneho pacienta ani konkrétny zdravotnícky výrobok.

Vek pri začatí liečby inhibítorom SGLT2, tehotenstvo po darovaní obličky, výber liečby anémie a záťaž spojená s diétnymi obmedzeniami boli témami rozhovoru Jennifer Abbasiovej s Keishou Gibsonovou v JAMA po kongrese Kidney Week 2026. Pre klinickú prax majú tieto správy odlišnú váhu: popri publikovanej kohortovej štúdii zahŕňajú kongresové abstrakty a následnú analýzu malej randomizovanej štúdie. Ich spoločným prínosom je presnejšie vymedzenie situácií, v ktorých treba liečbu prispôsobiť konkrétnemu pacientovi. [1]

Inhibítory SGLT2 u ľudí vo veku nad 80 rokov

Kongresová retrospektívna analýza databázy TriNetX sa venovala začatiu liečby inhibítormi sodíkovo-glukózového kotransportéra 2 (SGLT2) u pacientov s chronickou chorobou obličiek vo veku nad 80 rokov. Verejné podklady však nie sú zhodné. Abstrakt SA-OR031 uvádza po párovaní podľa skóre pravdepodobnosti liečby 23 765 pacientov v každej skupine a priaznivé asociácie s mortalitou aj súhrnnými kardiovaskulárnymi a obličkovými ukazovateľmi. Tlačová správa ASN uvádza 10 076 osôb a odlišné odhady vrátane vyššieho výskytu niektorých nežiaducich udalostí. [2, 3]

Môže ísť o rozdielne verzie analýzy, dostupné dokumenty to však nevysvetľujú. Kým sa tento nesúlad neobjasní, nemožno ich údaje spájať do jedného výsledku ani z nich vyvodzovať nový bezpečnostný profil liekov. Navyše retrospektívne párovanie neodstraňuje všetky rozdiely medzi liečenými a neliečenými pacientmi. Asociácia s nižšou mortalitou sama osebe nepreukazuje príčinný účinok. [2, 3]

Randomizované údaje pre starších ľudí pritom existujú. Vopred plánovaná analýza DAPA-CKD zahŕňala aj osemdesiatnikov a nezistila presvedčivý dôkaz, že by sa účinok dapagliflozínu líšil podľa veku. Celá štúdia zaradila 4 304 pacientov s odhadovanou glomerulovou filtráciou od 25 do 75 ml/min/1,73 m² a pomerom albumínu ku kreatinínu v moči od 200 do 5 000 mg/g. Výsledky sa teda týkajú vybranej populácie, nie

automaticky všetkých krehkých seniorov s chronickou chorobou obličiek. Tvrdenie, že osemdesiatnici boli zo všetkých veľkých skúšaní vylúčení, by bolo nepresné. [4]

Vek sám osebe preto nemá rozhodovať o odmietnutí liečby. Pri jej výbere treba rešpektovať indikáciu, funkciu obličiek, albuminúriu, srdcové zlyhávanie a celkový stav pacienta. KDIGO 2024 zároveň odlišuje očakávaný reverzibilný pokles odhadovanej glomerulovej filtrácie po začatí liečby od dôvodu na jej vysadenie a odporúča zvážiť dočasné prerušenie počas dlhšieho hladovania, operácie alebo kritického ochorenia. [4, 15]

Tehotenstvo po darovaní obličky

Kanadská štúdia publikovaná v JAMA porovnala 385 tehotenstiev u 252 žien po darovaní obličky s 1 540 párovanými tehotenstvami u 1 535 žien, ktoré obličku nedarovali. Zahŕňala jednoplodové tehotenstvá trvajúce aspoň 20 týždňov. Primárnym ukazovateľom bola hospitalizácia s gestačnou hypertenziou, preeklampsiou alebo eklampsiou. Vyskytla sa pri 46 tehotenstvách darkýň, teda pri 11,9 %, oproti 128 tehotenstvám v kontrolnej skupine, teda pri 8,3 %. Uvádzaný pomer rizík bol 1,51 s 95 % intervalom spoľahlivosti od 1,10 do 2,08. [5]

Rozdiel pozorovaných podielov predstavuje 3,6 percentuálneho bodu. Je to jednoduchý výpočet z publikovaných percent, nie upravený odhad príčinného účinku darovania. Rovnako pomer rizík 1,51 nemožno preložiť ako zvýšenie absolútneho rizika o 51 percentuálnych bodov. [5]

Väčšina tehotenstiev po darovaní obličky prebehla bez komplikácií. Výsledok podporuje informované poradenstvo pred darovaním a zohľadnenie anamnézy darovania pri prenatálnej starostlivosti. Neodôvodňuje plošné odmietanie darkýň, ktoré plánujú tehotenstvo. Keďže ide o observačnú štúdiu a sledovaný ukazovateľ vyžadoval hospitalizáciu, záver nemožno rozšíriť na všetky formy hypertenzie počas tehotenstva ani na skoré straty tehotenstva pred 20. týždňom. [5]

Vadadustat a význam správneho porovnania

Pragmatická randomizovaná štúdia prezentovaná v abstrakte FR-OR106 porovnávala vadadustat podávaný trikrát týždenne s epoetínom alfa v 161 hemodialyzačných pracoviskách. Randomizovaných bolo 2 116 pacientov; aspoň jednu dávku dostalo 1 973. Hierarchický kombinovaný ukazovateľ úmrtia a hospitalizácie vyznel priaznivejšie pri vadadustate, predovšetkým vďaka hospitalizáciám. Pomer incidencií mortality bol 1,00 s 95 % intervalom spoľahlivosti od 0,72 do 1,39. Pokles mortality sa teda nepreukázal. [6]

Ide zatiaľ o kongresové výsledky. Predčasné ukončenie po priebežnej analýze a rozdielna priemerná dĺžka expozície vyžadujú posúdenie plnej publikácie. Percentuálne podiely závažných nežiaducich udalostí nemožno bez zohľadnenia času sledovania pokladať za priamy dôkaz vyššej bezpečnosti. [6]

Staršie skúšania INNO2VATE u dialyzovaných pacientov preukázali noninferioritu vadadustatu oproti darbepoetínu alfa pri kardiovaskulárnej bezpečnosti a korekcii a udržiavaní hemoglobínu. To neznamená superioritu ani úplnú rovnocennosť. Navyše v inom publikovanom skúšaní režim trikrát týždenne nesplnil vopred určenú hranicu noninferiority pre zmenu hemoglobínu oproti darbepoetínu alfa, hoci denný režim ju splnil. Výsledky rozdielnych režimov, komparátorov a ukazovateľov nemožno zamieňať. [7, 8]

Vadadustat patrí medzi inhibítory prolylhydroxylázy hypoxiou indukovateľného faktora (HIF-PHI). Podľa európskeho súhrnu charakteristických vlastností lieku je určený na symptomatickú anémiu pri chronickej chorobe obličiek u dospelých na chronickej udržiavacej dialýze; schválené podávanie je raz denne. Kongresový režim trikrát týždenne preto nepredstavuje automatickú zmenu schváleného dávkovania. Pred liečbou aj počas nej sa má hodnotiť stav železa a podľa potreby ho doplňať. Mechanizmus účinku neznamená nezávislosť od zásob železa. [9]

KDIGO 2026 po riešení odstrániteľných príčin anémie navrhuje ako prvú voľbu látky stimulujúce erytropoézu (ESA) pred HIF-PHI, so silou odporúčania 2D. Nové kongresové údaje sú dôvodom na ďalšie hodnotenie, samy však tento postup nenahrádzajú. [10]

Viazač draslíka a záťaž diétnych obmedzení

Otvorená randomizovaná štúdia Y-QOL hodnotila cyklosilikát sodno-zirkoničitý (SZC) spolu so štandardizovaným nutričným poradenstvom oproti samotnému poradenstvu. Zaradení boli hemodialyzovaní pacienti s hyperkaliémiou. Z 196 randomizovaných pacientov vstúpilo do primárnej analýzy 183. Po ôsmich týždňoch bol

upravený rozdiel v zmene skóre QDIS-7 medzi skupinami -3,8 bodu s 95 % intervalom spoľahlivosti od -4,9 do -2,7, v prospech SZC. Pokles predialyzačnej kaliémie bol väčší pri SZC. [11]

Pre pacienta je dôležitá aj menšia záťaž spojená s obmedzovaním stravy. Výsledok však pochádza z kongresového abstraktu a subjektívny ukazovateľ mohol ovplyvniť otvorený dizajn. Protokol štúdie je samostatne publikovaný, nenahrádza však úplnú výsledkovú prácu. Osemtýždňové sledovanie nepreukazuje dlhodobé zníženie arytmií či mortality a neoprávňuje k neobmedzenému príjmu draslíka. [11, 12]

Ovocie, zelenina a metabolická acidóza

Desaťročná analýza zahŕňala 108 pacientov bez diabetu s chronickou chorobou obličiek kategórie G3, výraznou albuminúriou a celkovým CO2 v plazme od 22 do 24 mmol/l. Po 36 účastníkov dostávalo ovocie a zeleninu na zníženie kyselinovej záťaže, hydrogénuhličitan sodný alebo obvyklú starostlivosť. Náhradu funkcie obličiek začali štyria účastníci v skupine s ovocím a zeleninou oproti šestnástim pri obvyklej starostlivosti. [13]

Hospitalizácie, návštevy urgentného príjmu a náklady sa hodnotili v následnej analýze. Abstrakt uvádza nižšie počty hospitalizácií a návštev urgentného príjmu pri ovocí a zelenine, celkové desaťročné náklady sa však medzi skupinami nelíšili. Pomalší rast nákladov a modelové odhady pre desiaty rok nie sú totožné s preukázanou úsporou za celé obdobie. Ani výsledok s p = 0,051 pri porovnaní začatia náhrady funkcie obličiek medzi hydrogénuhličitanom a obvyklou starostlivosťou nedokazuje neprítomnosť účinku. [13]

Pôvodná trojročná publikácia tejto výskumnej línie podporila priaznivý účinok oboch alkalizačných zásahov na pokles odhadovanej glomerulovej filtrácie. Súbor bol malý a výberový. Celkový CO2 od 22 do 24 mmol/l navyše nemožno bez ďalšieho označiť za závažnú metabolickú acidózu ani za univerzálny prah na farmakologickú liečbu. KDIGO 2024 pri zvažovaní liečby uvádza ako príklad acidózy s možnými klinickými dôsledkami sérový hydrogénuhličitan pod 18 mmol/l a požaduje sledovanie tlaku, kaliémie a objemového stavu. [14, 15]

Dôsledky pre každodennú prax

Tieto práce pomáhajú spresniť rozhodovanie, nie vytvoriť jednotný postup pre všetkých pacientov. Pri seniorovi má výber inhibítora SGLT2 vychádzať z overenej indikácie a celkového stavu. U potenciálnej darkyne treba hovoriť aj o neskoršom tehotenstve. Pri anémii treba oddeliť registrovaný režim od skúšaného a pri hyperkaliémii posudzovať spolu kaliémiu, nutričnú kvalitu stravy a každodennú liečebnú záťaž. [4, 5, 9, 10, 11]

Najmä diétne výsledky vyžadujú zachovanie hraníc skúmanej populácie. Zistenia u vybraných pacientov s G3 nemožno priamo preniesť na človeka s pokročilým zlyhaním obličiek a opakovanou hyperkaliémiou. Menšia záťaž liečby má klinickú hodnotu vtedy, keď sa dosiahne pri zachovaní bezpečnosti a primeranej výživy. [11, 13, 15]

Zdroje

1. Jennifer Abbasi. SGLT2 Inhibitors, Potassium Binders, Pregnancy After Kidney Donation, and More From Kidney Week. JAMA. 2026 Nov 06; online pred zaradením do čísla. DOI: 10.1001/jama.2026.19959. PubMed, PMID 42993529. Vydavateľ.

2. Julian Doricic, Jonas Michael Willerding, Anette Melk, Kai M. Schmidt-Ott, Robert Greite, Wilfried Gwinner, Bernhard M. W. Schmidt. Extending Benefit to the Oldest Old: Efficacy of SGLT2 Inhibitors in Older Adults with CKD. ASN Kidney Week 2026. 2026. Kongresový abstrakt SA-OR031. DOI a PMID v použitom zázname neuvedené. Pôvodný dokument.

3. American Society of Nephrology. Advanced Age Does Not Limit the Benefits of Sodium-Glucose Cotransporter 2 Inhibitors in Chronic Kidney Disease. ASN. 24. októbra 2026. Tlačová správa, nie pôvodná publikácia. DOI a PMID v použitom dokumente neuvedené. Pôvodný dokument.

4. Margaret K Yu, Priya Vart, Niels Jongs, Ricardo Correa-Rotter, Peter Rossing, John J V McMurray, Fan-Fan Hou, Walter Douthat, Dinesh Khullar, Anna Maria Langkilde, David C Wheeler, Hiddo J L Heerspink, Glenn M Chertow. Effects of Dapagliflozin in Chronic Kidney Disease Across the Spectrum of Age and by Sex. Journal of general internal medicine. 2024 May; 39(6):921-930. DOI: 10.1007/s11606-023-08397-9. PubMed, PMID 38097862. Vydavateľ.

5. Carol Wang, Kyla L Naylor, Eric McArthur, James A King, Jessica M Sontrop, Joseph Beyene, Dervla Connaughton, Elizabeth Hendren, Michelle Hladunewich, Ngan N Lam, Krista L Lentine, Rhiannon Lyons, Sarah D McDonald, Pavel S Roshanov, Erik Youngson, Amit X Garg. Pregnancy Outcomes After Living Kidney Donation. JAMA. 2026 Oct 22; e2621737. DOI: 10.1001/jama.2026.21737. PubMed, PMID 42914154. Vydavateľ.

6. Shuchi Anand, Glenn M. Chertow, Myles Wolf, Mary O. Dittrich, Gopa Green, Martha Block, Adrian E. Elorriaga, Stephanie Brillhart, Amanda Leppink, F. David Newby, Carolina Arias, Ayodele Erinle, Irfan Agha, Geoffrey A. Block. Vadadustat Three Times Weekly for the Treatment of Anemia in Patients Receiving Hemodialysis. ASN Kidney Week 2026. 2026. Kongresový abstrakt FR-OR106. DOI a PMID v použitom zázname neuvedené. Pôvodný dokument.

7. Kai-Uwe Eckardt, Rajiv Agarwal, Ahmad Aswad, Ahmed Awad, Geoffrey A Block, Marcelo R Bacci, Youssef M K Farag, Steven Fishbane, Harold Hubert, Alan Jardine, Zeeshan Khawaja, Mark J Koury, Bradley J Maroni, Kunihiro Matsushita, Peter A McCullough, Eldrin F Lewis, Wenli Luo, Patrick S Parfrey, Pablo Pergola, Mark J Sarnak, Bruce Spinowitz, James Tumlin, Dennis L Vargo, Kimberly A Walters, Wolfgang C Winkelmayer, Janet Wittes, Rafal Zwiech, Glenn M Chertow. Safety and Efficacy of Vadadustat for Anemia in Patients Undergoing Dialysis. The New England journal of medicine. 2021 Apr 29; 384(17):1601-1612. DOI: 10.1056/NEJMoa2025956. PubMed, PMID 33913638. Vydavateľ.

8. Laura Kooienga, Steven Burke, Amarnath Kathresal, Wenli Luo, Zhihui Yang, Zhiqun Zhang, Rafal Zwiech, German T Hernandez. Safety and Efficacy of Vadadustat Once Daily and Three Times Weekly in Patients With Dialysis-Dependent CKD With Anemia. Kidney360. 2024 Nov 01; 5(11):1652-1661. DOI: 10.34067/KID.0000000567. PubMed, PMID 39231617. Vydavateľ.

9. European Medicines Agency. Vafseo (vadadustat). Súhrn charakteristických vlastností lieku. EMA. aktuálny dokument načítaný 8. novembra 2026. Časti 4.1 a 4.2. DOI a PMID sa na tento regulačný dokument nevzťahujú. Pôvodný dokument.

10. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Anemia Work Group. KDIGO 2026 Clinical Practice Guideline for the Management of Anemia in Chronic Kidney Disease (CKD). Kidney international. 2026 Jan; 109(1S):S1-S99. DOI: 10.1016/j.kint.2025.06.006. PubMed, PMID 41485812. Vydavateľ.

11. Hiromichi Wakui, Daisuke Kanai, Shiori Yoshimura, Rika Furuta, Shunichi Fukuhara, Sayaka Shimizu, Yusuke Saigusa, Masaaki Hanaoka, Hiroshi Mitsuhashi, Tomoyuki Kawano, Mari Katsumata, Satoshi Yamaguchi, Nariaki Ogawa, Masato Ohsawa, Kohji Ohki, Sho Kinguchi, Kengo Azushima, Yoshiyuki Toya, Takeo Ishii, Ashio Yoshimura, Shohei Sato, Gen Yasuda, Tadashi Kuji, Toshimasa Oonishi, Kouichi Tamura. Sodium Zirconium Cyclosilicate and Quality of Life in Patients with Hyperkalemia on Hemodialysis: The Randomized Y-QOL Study. ASN Kidney Week 2026. 2026. Kongresový abstrakt TH-OR084. DOI a PMID v použitom zázname neuvedené. Pôvodný dokument.

12. Shiori Yoshimura, Daisuke Kanai, Hiromichi Wakui, Rika Furuta, Shunichi Fukuhara, Sayaka Shimizu, Kouji Yamamoto, Yusuke Saigusa, Masaaki Hanaoka, Hiroshi Mitsuhashi, Tomoyuki Kawano, Mari Katsumata, Satoshi Yamaguchi, Nariaki Ogawa, Masato Ohsawa, Kohji Ohki, Masahiro Nishihara, Sho Kinguchi, Kengo Azushima, Tomohiko Kanaoka, Yusuke Kobayashi, Yoshiyuki Toya, Takeo Ishii, Ashio Yoshimura, Gen Yasuda, Tadashi Kuji, Toshimasa Ohnishi, Kouichi Tamura. Effects of sodium zirconium cyclosilicate on the quality of life of patients with hyperkalemia undergoing hemodialysis: Y-QOL study design. BMC nephrology. 2025 Sep 26; 26(1):531. DOI: 10.1186/s12882-025-04429-0. PubMed, PMID 41013395. Vydavateľ.

13. Nimrit Goraya, Nazan Aksan, Maninder Kahlon, Jan Simoni, Inka Leprince, Elizabeth Li, Donald E. Wesson. Long-Term Outcomes and Health Care Costs of Fruits and Vegetables vs. Sodium Bicarbonate or Usual Care for Metabolic Acidosis in CKD: Post Hoc Analysis of a 10-Year Randomized Trial. ASN Kidney Week 2026. 2026. Kongresový abstrakt TH-OR054. DOI a PMID v použitom zázname neuvedené. Pôvodný dokument.

14. Nimrit Goraya, Jan Simoni, Chan-Hee Jo, Donald E Wesson. Treatment of metabolic acidosis in patients with stage 3 chronic kidney disease with fruits and vegetables or oral bicarbonate reduces urine angiotensinogen and preserves glomerular filtration rate. Kidney international. 2014 Nov; 86(5):1031-8. DOI: 10.1038/ki.2014.83. PubMed, PMID 24694986. Vydavateľ.

15. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group. KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. Kidney international. 2024 Apr; 105(4S):S117-S314. DOI: 10.1016/j.kint.2023.10.018. PubMed, PMID 38490803. Vydavateľ.

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=kidney-week-2026-sglt2-darcovstvo-anemia-hyperkaliemia · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.